



2024 - 2025

FACULTÉ DE MÉDECINE

Unité d'Introduction à la
Démarche Clinique

1^{re} année Master

Compétences Cliniques et Dimensions Communautaires

Cahier de l'étudiant-e



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE MÉDECINE

Unité d'Introduction à la Démarche Clinique

Section CC et DC

1^{re} année Master

TABLE DES MATIERES

COMPETENCES CLINIQUES	3
STATION FORMATIVE AVEC PATIENT(E) INSTRUCTEUR(TRICE).....	5
SEMIOLOGIE PEDIATRIQUE 1.....	7
SEMIOLOGIE PEDIATRIQUE 2.....	9
SEMIOLOGIE DU DIABETE	11
SEMIOLOGIE DE LA THYROIDE	15
ELECTROCARDIOGRAPHIE CLINIQUE 1, 2 et 3	19
CARDIOLOGIE CLINIQUE.....	21
EVALUATION FONCTIONNELLE : exemple gériatrique.....	25
EXAMEN PHYSIQUE GENERAL DE L'ADULTE	27
ANALYSE DES GAZ SANGUINS	37
TRANSFUSIONS SANGUINES	39
LABORATOIRE 4	41
COMMUNICATION EN MILIEU CLINIQUE 9 « Annonce d'une mauvaise nouvelle »	43
COMMUNICATION EN MILIEU CLINIQUE 10 « Mener un entretien avec un.e adolescent.e / jeune adulte »	45
EXAMEN BUCCO-DENTAIRE	45
EXAMEN ORL DE BASE	52
URGENCES : REFRESH REANIMATION	54
RADIOLOGIE « Lecture d'une image radiologique conventionnelle du thorax »	56
RADIOLOGIE « Approche interactive à l'imagerie de l'abdomen aigu »	58
RADIOLOGIE « Lecture d'une image radiologique conventionnelle en ostéoarticulaire »	60
COURS SUTURA.....	62

TABLE DES MATIERES (SUITE)

DIMENSIONS COMMUNAUTAIRES	64
QUALITES DES SOINS	66
QUALITE DES SOINS 1.....	68
QUALITE DES SOINS 2.....	70
MEDECINE ET SOINS PALLIATIFS.....	72
MEDECINE LEGALE ET ETHIQUE 1 : " Prise de décision et capacité de discernement "	74
MÉDECINE LÉGALE 3.....	76
MÉDECINE LÉGALE 4.....	78

SECTION CC

COMPETENCES CLINIQUES

STATION FORMATIVE AVEC PATIENT(E) INSTRUCTEUR(TRICE)

OBJECTIFS DE LA STATION

Les patients instructeurs sont de vrais patients qui offrent la possibilité aux étudiants de mieux connaître une maladie chronique et invalidante, la polyarthrite rhumatoïde.

L'anamnèse et l'examen physique de ces malades vont permettre aux étudiants d'explorer les caractéristiques sémiologiques, les lésions physiques et les répercussions psycho-sociales associées à cette maladie.

Au cours de ces entretiens, les étudiants bénéficient d'un feed-back des patients instructeurs sur les aspects bio-médicaux et relationnels.

Dates et Horaire :

Un horaire de passage détaillé vous parviendra par mail, l'information sera également déposée sur le site de l'unité UIDC.

La participation à cette station est obligatoire, merci de respecter scrupuleusement les horaires indiqués.

SEMILOGIE PEDIATRIQUE 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Dr Daivy Benador, praticien, tél. 022 / 343 50 75

THEME DU SEMINAIRE

- Introduction à l'anamnèse du nourrisson et de l'enfant d'âge préscolaire.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 18 étudiant-e-x-s.
- Jeux de rôle.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Réaliser quelles sont les particularités d'une anamnèse pédiatrique en fonction de l'âge de l'enfant.
- - Connaître les principales caractéristiques de la croissance des nourrissons et des enfants,
 - connaître les grandes étapes de leur développement,
 - connaître les principaux facteurs leur permettant d'avoir une croissance et un développement harmonieux.

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Jeux de rôle permettant aux étudiant-e-x-s d'être confrontés à des moments différents de la vie de l'enfant sain.

Discussion et approfondissement des notions importantes de l'anamnèse selon l'âge de l'enfant.

La première heure est consacrée aux nourrissons, la seconde à l'enfant d'âge préscolaire.

PREMIERE HEURE

SITUATION DU JEU DE ROLE :

"Un couple de 27 ans amène son enfant âgé de 1 mois chez le pédiatre pour un premier contrôle. Le pédiatre a reçu de la maternité un document contenant entre autres les informations suivantes : mère 1 paré, 1 geste de 27 ans sans antécédent particulier. La grossesse est d'évolution favorable avec un accouchement par voie basse à 40 semaines de gestation. APGAR 9/10/10, poids de naissance 3,2 kg (moyenne), taille 51 cm (+0,5 DS), périmètre crânien 34 cm (moyenne), sexe féminin, les status au premier jour de vie et au 4e jour de vie (moment où l'enfant quitte la maternité) sont dans les limites de la norme. A sa sortie, les mensurations du bébé sont identiques au premier jour de vie pour la taille et le périmètre crânien, son poids est de 3,1 kg."

- Après lecture, les points importants de cet énoncé sont discutés.
- 3 étudiant-e-x-s jouent ensuite les rôles des 2 parents et de la ou du pédiatre.
- Discussion sur ce qui a été joué et approfondissement des points et notions importantes de l'anamnèse des enfants de cet âge.

DEUXIEME HEURE

SITUATION DU JEU DE ROLE :

"Une famille vient de déménager à Genève. Le fils aîné est âgé de 5,5 ans et ses parents l'amènent chez la/le pédiatre, qui ne connaît pas encore l'enfant, pour un contrôle avant sa prochaine scolarisation. L'enfant est en bonne santé habituelle".

- Même démarche ensuite que pour la première heure.

SEMIOLOGIE PEDIATRIQUE 2

PERSONNE CONCERNÉE

Responsable du séminaire

Dr Daivy Benador, praticien, tél. 022 / 343 50 75

THEME DU SEMINAIRE

- Introduction à l'anamnèse de l'adolescent-e.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Sessions de 2h.
- Groupe d'env. 18 étudiant-e-x-s.
- Jeu de rôle.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Réaliser quelles sont les particularités d'une anamnèse de l'adolescent.
- Les points suivants feront l'objet d'une attention particulière :
 - chronologie des premiers signes de puberté, âge de la ménarche, et comment les changements pubertaires sont vécus,
 - problèmes liés au poids,
 - nutrition,
 - état de scolarisation et projets professionnels,
 - problèmes relationnels avec la famille ou avec les pairs,
 - conduites à risque: tabagisme, relations sexuelles non protégées, drogues,
 - état des connaissances sur les mesures préventives (SIDA, contraception).

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

SITUATION DU JEU DE ROLE :

"Une adolescente de 14 ans vient trouver son/sa pédiatre habituel avec ses parents. La mère est inquiète car sa fille n'est pas encore réglée et le père est inquiet car sa fille fréquente déjà un petit copain. Ils aimeraient savoir si tout cela est normal car depuis quelques mois leur relation avec leur fille s'est détériorée. D'ailleurs, notre adolescente semble agacée, elle hausse souvent les épaules dès qu'un de ses parents dit quelque chose."

- 4 étudiant-e-x-s jouent les rôles des parents, de l'adolescente et du pédiatre.
- Discussion ensuite sur ce qui a été joué et approfondissement des points et notions importantes de l'anamnèse des adolescent-e-s.

SEMILOGIE DU DIABETE

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire

Prof François Jornayvaz, tél. 022 / (37) 29 302

Veillez vous munir d'une blouse

Dans la mesure du possible, vous aurez l'occasion d'interroger et examiner un-e patient-e présentant une complication du diabète. Alternativement, un examen du pied diabétique sera fait sur un-e étudiant-e volontaire.

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse diabétologique et examen du pied diabétique.

OBJECTIFS

- Reconnaître dans l'anamnèse les symptômes suggestifs d'un diabète et identifier les facteurs de risque.
- Reconnaître que le diabète est la plupart du temps une maladie silencieuse.
- Reconnaître dans l'anamnèse les symptômes liés aux complications chroniques du diabète.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiant-e-s.
- Jeu de rôle.
- Examen du pied diabétique d'un-e patient-e souffrant de diabète.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroulera en deux phases.

PREMIERE PARTIE

Cette partie consistera en un jeu de rôle entre les étudiant-e-s représentant le médecin qui jouera le rôle du patient.

La patiente est une femme de 68 ans, obèse (98 kg pour 176 cm) affectée d'un diabète depuis l'âge de 52 ans. Elle a une hypertension artérielle et une dyslipidémie.

L'anamnèse doit relever les points suivants :

- Anamnèse diabétologique :
 - durée du diabète,
 - traitements successifs,
 - qualité du contrôle métabolique,
 - auto-contrôles sanguins : horaires et fréquences,
 - poids : évolution,
 - régime : anamnèse alimentaire,
 - exercice physique,
 - symptômes d'hyper- et d'hypoglycémie (polyurie, polydipsie, flou visuel, fatigue, et transpirations, tremblements, maux de tête, pâleur, changement de caractère), et antécédents de décompensation ou hypoglycémie sévère.
 - Comorbidités.
- Complications chroniques du diabète (souligner que les symptômes peuvent être souvent absents ou atypiques) :
 - macroangiopathiques :
 - cardiopathie ischémique,
 - insuffisance artérielle périphérique,
 - accidents vasculaires cérébraux.
 - microangiopathiques :
 - présence de rétinopathie :
 - antécédents de traitement au laser/injections,
 - baisse de l'acuité visuelle, épisodes de flou visuel,
 - présence de néphropathie,
 - présence de neuropathie somatique (sensitivo-motrice) :
 - brûlures, crampes, dysesthésie,
 - antécédents d'ulcères au pied,
 - présence de neuropathie du système nerveux autonome :
 - intolérance à l'effort;
 - hypotension orthostatique;
 - gastroparésie;
 - diarrhées, constipation;
 - impuissance;
 - éjaculation rétrograde;
 - sécheresse de la peau (partie inférieure du corps);
 - transpiration excessive (partie supérieure du corps);
 - troubles vésicaux.

- Anamnèse psycho-sociale.
- Facteurs de risque cardio-vasculaire :
 - tabagisme,
 - hypertension artérielle,
 - anamnèse familiale positive,
 - dyslipidémie.
- Anamnèse familiale :
 - diabète,
 - complications chroniques du diabète,
 - cardiopathie ischémique,
 - HTA, dyslipidémie.

DEUXIEME PARTIE

Cette partie se passera si possible au lit d'un-e patient-e diabétique de type 2 pour faire l'examen d'un pied diabétique (neuropathie et artériopathie), sinon sur un-e étudiant-e volontaire. On insistera sur l'examen de :

- L'arbre artériel : palpation et auscultation des artères :
 - fémorales,
 - poplitées,
 - tibiales postérieures,
 - pédieuses.
- L'examen neurologique :
 - sensibilité touché/piqué,
 - température,
 - pallesthésie,
 - réflexes ostéotendineux (surtout achilléens et rotuliens).
- Les pieds :
 - dilatation veineuse,
 - sécheresse de la peau,
 - hyperkératose, crevasses,
 - déformations ostéo-articulaires,
 - lésions cutanées,
 - mycose interdigitale,
 - onychomycose.

SEMIOLOGIE DE LA THYROIDE

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Prof. Jacques Philippe, tél. 022 / (37) 29 302

Veillez vous munir d'une blouse

Dans la mesure du possible, vous aurez l'occasion d'interroger et examiner un patient présentant un problème thyroïdien.

THEME DU SEMINAIRE

- Sémiologie des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS

- Acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées aux répercussions fonctionnelles des troubles thyroïdiens.
- Palpation de la glande thyroïde.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiants.
- Jeu du rôle.

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroulera en deux phases.

PREMIERE PARTIE

Cette partie doit permettre aux étudiants de développer leurs aptitudes à prendre une anamnèse dirigée sur les troubles fonctionnels liés à une dysthyroïdie. Elle consistera en une prise de l'anamnèse et un examen de la thyroïde par les étudiants lors d'un jeu de rôle, par une critique du formateur (environ 10 minutes) et par une synthèse finale effectuée par le groupe d'étudiants (10 minutes).

PROPOSITION POUR UN JEU DE ROLE

Patiente qui prend un rendez-vous pour une perte de poids

Histoire du cas

Patiente de 40 ans qui a perdu 8 kg en 6 mois malgré un bon appétit. Elle se plaint d'être irritable, d'avoir de la peine à s'endormir et de toujours transpirer. Elle n'a pas de traitement.

DEUXIEME PARTIE

Cette phase se résumera à la prise d'une anamnèse d'un patient souffrant réellement d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie (environ 30 minutes) et d'un examen de la thyroïde. Cette étape sera suivie d'une synthèse des plaintes du patient et de la vraisemblance de ses plaintes à entrer dans le diagnostic des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

ANAMNESE

- Rechercher les symptômes d'une dysthyroïdie :
 - palpitations;
 - variations du poids corporel;
 - troubles : de l'humeur
 du sommeil
 de la voix
 du transit gastro-intestinal
 du cycle menstruel
 - changement au niveau : de la peau;
 des ongles;
 - perte d'énergie, diminution de la force musculaire;
 - changement de la voix;
 - problèmes oculaires;
 - transpiration, tolérance à la chaleur.
 - gêne au niveau du cou (gêne à la déglutition, douleurs)
- Antécédents personnels et familiaux :
 - thyroïdiens;
 - autres maladies auto-immunes.
- Médicaments, iode (scanner injecté récemment, coronarographie, Amiodarone, accouchement récent)

EXAMEN DU PATIENT

- Agitation, tremblement, ralentissement ;
- Tension artérielle ;
- Tachycardie ou bradycardie ;
- Force musculaire ;
- Examen des yeux : - signes de Graefe, brillance du regard;
 - ophtalmopathie.
- Onycholyse, dermopathie ;
- Sécheresse de la peau ou transpiration excessive ;
- Examen de la glande thyroïde : - recherche de goitre/nodule
 - recherche de sensibilité à la palpation
- Temps de relaxation des réflexes ostéo-tendineux.

ELECTROCARDIOGRAPHIE CLINIQUE 1, 2 et 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire

Prof. H. Burri, HUG, 022/372 72 00

THEME DU SEMINAIRE

- Lecture systématique de l'ECG.

OBJECTIFS GENERAUX

- Savoir interpréter systématiquement un ECG normal: analyse systématique ; mesures et valeurs normales ; calcul de l'axe électrique du cœur ;
- Savoir reconnaître les principales anomalies ECG : dysfonction sinusale, bloc auriculo-ventriculaire (1,2 et 3), bloc de branche droit et gauche, extrasystoles et tachycardies supra-ventriculaires et ventriculaire, hypertrophie atriale et ventriculaire, ischémie et infarctus, péricardite, troubles électrolytiques.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- E-learning obligatoire et au moyen d'un polycopié téléchargeable sur Moodle (extrait du livre « ECG from basics to essentials »)
- Sessions de 2x2heures (ECG1 et ECG2) en groupes de tiers de volée avec exercices de lecture systématique par les étudiants (matériel à télécharger sur Moodle)
- Quiz ECG en ligne obligatoire à compléter sur Moodle.
- Revue du quiz en plus petits groupes de sixièmes de volées

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

Les bases de la lecture de l'ECG doivent déjà être acquises par les cours et travaux pratiques des années antérieures, et surtout par la lecture obligatoire et indispensable du polycopié disponible sur le site Moodle. Sans cette préparation, il sera très difficile de suivre les cours, qui sont denses.

Le formateur procédera en premier lieu à un bref rappel des notions de base. Les étudiants procéderont ensuite à l'analyse de tracés anormaux, en se concentrant sur la systématique de la lecture ECG. Les anomalies ECG spécifiques seront abordées sur la base de tracés démonstratifs téléchargeable préalablement depuis le site Moodle. Ces exercices (ECG 1 et 2) auront lieu durant 2x2 heures en tiers de volées.

Les étudiants devront ensuite obligatoirement compléter un quiz ECG sur le site Moodle qui couvre les différentes pathologies étudiées. La participation au quiz par chaque étudiant est vérifiable et sera contrôlée par le tuteur. Ce quiz permettra d'exercer et réviser les connaissances acquises lors des modules préalables.

Ce quiz sera ensuite discuté lors d'un troisième séminaire (ECG 3) de 2 heures effectué en plus petit groupe de sixième de volée.

CARDIOLOGIE CLINIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Prof Marco Roffi, tél 022 / (37) 27 208

THEME DU SEMINAIRE

- Auscultation cardiaque.

OBJECTIFS

- Entraîner la technique de l'auscultation cardiaque.
- Reconnaître une auscultation cardiaque pathologique et savoir décrire les phénomènes acoustiques.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupes d'env. 9 étudiant.e.s par formateur/formatrice, un formateur/formatrice supplémentaire pendant la deuxième heure au lit du malade (1/2 groupe par patient,e et formateur/formatrice).
- Répétition de l'examen clinique du cœur et de la technique d'auscultation.
- Simulation d'auscultation pathologique à l'aide du mannequin d'auscultation SAM II:
- :
 - Auscultation normale (B1, B2, dédoublement physiologique de B2), B3, B4.
 - Sténose aortique.
 - Insuffisance mitrale.
 - Insuffisance aortique.
- Examen d'un patient par 4-5 étudiant.e.s:
 - courte anamnèse et pratique de l'inspection et palpation.
 - auscultation.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

- Les informations concernant les noms, unités, chambres et diagnostics des deux patients sollicités par groupe pour l'enseignement de l'auscultation sont disponibles au secrétariat du Prof. Roffi, une demi-heure avant le début du séminaire, afin de permettre aux formateurs de visiter et ausculter le patient avant le séminaire.

PREMIERE PARTIE (ENVIRON 60 MINUTES)

- Le formateur rappelle brièvement les différents éléments de l'examen physique du cœur:

Inspection: - couleur de la peau;
- veines jugulaires;
- pulsations précordiales, choc de pointe visible;
- pulsations artérielles.

Palpation: - pouls carotidien;
- choc de pointe;
- aire précordiale.

Auscultation: - foyers d'auscultation;
- auscultation normale.

(Pour détails voir CCs "Circulation 2" et "Circulation 4", Unité "Cœur et Circulation", 2^{ème} année)

Par la suite, démonstration à l'aide du mannequin d'auscultation SAM II:

- de la relation entre les phénomènes acoustiques normaux et les différents événements du cycle cardiaque;
- de la relation entre l'hémodynamique, la forme et la localisation du souffle dans le cycle cardiaque dans la sténose aortique, l'insuffisance mitrale, et l'insuffisance aortique.

DEUXIEME PARTIE (ENVIRON 45 MINUTES)

- Cette partie est consacrée à l'examen d'un.e patient.e qui présente un souffle cardiaque. A ce propos, le groupe est divisé en deux, et quatre-cinq étudiant.e.s effectuent l'examen d'un patient avec un formateur/une formatrice dans l'unité dans laquelle le/la patient.e est hospitalisé.e.
- Le formateur/la formatrice informe les étudiant.e.s qu'il faut faire une courte anamnèse, ciblée sur le système cardiaque; puis passer à l'inspection et la palpation à la recherche des signes d'une affection cardiaque. Ces trois phases initiales peuvent être réparties entre trois étudiant.e.s du groupe.
- Par la suite, tous les étudiant.e.s du groupe auscultent le cœur. Le formateur/la formatrice discute les observations faites à l'auscultation. Des réflexions sont menées quant au diagnostic. Une répétition de l'auscultation de certains foyers, avec connaissance des phénomènes acoustiques, peut suivre.
- Le choix des objectifs dépend des patients à disposition pour le séminaire. L'accent sera mis sur la technique de l'auscultation et la description des phénomènes acoustiques.

a) *Savoir interpréter les altérations à l'inspection et à la palpation*

Stase jugulaire:	élévation de la pression dans l'oreillette droite	
Pouls carotidien:	pouls tardif pouls ample et bondissant	→ sténose aortique → augmentation du volume d'éjection (insuffisance aortique)
Choc de pointe:	élargi et déplacé vers la gauche	→ surcharge en volume ou insuffisance du myocarde ventriculaire gauche

b) *Pouvoir décrire l'auscultation cardiaque*

Bruits:	intensité	
	fréquence	(haute fréquence: BII)
	rapports chronologiques	(BI avec montée simultanée du pouls carotidien)
	éventuellement timbre	(par ex.: "métallique": prothèse valvulaire)
Souffles:	rapports chronologiques	(systolique, diastolique)
	morphologie	[decrecendo, crescendo-decrecendo (en losange), rectangulaire]
	fréquence	[haute fréquence (insuffisance aortique)]
	intensité	degré 1 = très léger
		degré 2 = léger, mais que l'on entend immédiatement en posant le stéthoscope
		degré 3 = souffle d'intensité moyenne
		degré 4 = souffle d'intensité forte
		degré 5 = souffle très fort, que l'on n'entend plus en éloignant le stéthoscope
		degré 6 = souffle très fort, audible à distance, le stéthoscope ne touchant pas la paroi thoracique
	localisation	(mais : la localisation de l'intensité maximale ne permet souvent pas d'identifier l'origine du souffle)
	irradiation	(irradiation dans la direction du flux sanguin) ; sténose aortique → artères carotides

c) *Pouvoir mener des réflexions quant à la localisation et le type de la valvulopathie*

- souffle protomésosystolique, irradiant dans les carotides → sténose aortique;
- souffle holosystolique, irradiant dans l'aisselle → insuffisance mitrale;
- souffle proto-mésodiastolique de haute fréquence au mésocarde → insuffisance aortique.

d) *Connaître le lien entre la forme du souffle et le gradient de pression*

La forme du souffle reflète grossièrement l'évolution du gradient de pression entre la structure en amont et en aval de la valve.

Remarque: L'intensité du souffle est peu utile pour apprécier la sévérité de la valvulopathie.

e) *Savoir qu'il existe des souffles cardiaques sans anomalie structurelle du cœur*

- souffle systolique fonctionnel :
- s'arrête bien avant le deuxième bruit
 - disparaît en général à la manœuvre de Valsalva.

Chaque augmentation du débit sanguin peut provoquer un souffle d'éjection sans sténose valvulaire (effort, émotion, grossesse, anémie, fièvre, souffle systolique dans l'insuffisance aortique).

EVALUATION FONCTIONNELLE : exemple gériatrique

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Docteure Aline Mendes - tél. 079 / 553 83 65

Docteur Samuel Périvier - tél. 022 / 553 83 06

Thème du séminaire

- Principes de base et utilité de l'évaluation fonctionnelle.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Comprendre qu'un diagnostic médical ne permet pas, à lui seul, d'évaluer les capacités fonctionnelles d'une personne.
- Comprendre la variabilité du retentissement fonctionnel des maladies sur les personnes.
- Savoir évaluer les activités de la vie quotidienne (AVQ): exemple de l'échelle de Katz.
- Savoir évaluer les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ): exemple de l'échelle de Lawton.
- Savoir évaluer le réseau social.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Groupes d'env. 16 étudiant-es en parallèle.
- Un médecin, quatre ergothérapeutes et quatre physiothérapeutes par groupe.
- Ateliers permettant d'expérimenter l'impact d'un handicap sur les activités de la vie quotidienne: parcours de réhabilitation, tâches de la vie quotidienne.
- Analyse d'un projet de retour à domicile.
- Présentation d'échelles d'évaluation existantes.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

- Les deux objectifs généraux du séminaire sont :
 - 1) de comprendre l'utilité d'une évaluation fonctionnelle lors de la prise en charge d'un-e patient-e afin de pouvoir choisir une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée.
 - 2) comprendre pourquoi un diagnostic médical ne permet pas, à lui seul, d'évaluer l'impact d'une maladie sur les capacités fonctionnelles d'une personne.
- Afin de pouvoir expérimenter l'impact d'un handicap, les étudiant-es seront munis d'appareils simulants des handicaps et effectueront un parcours de réhabilitation ou des gestes de la vie quotidienne. Cette expérience sera ultérieurement discutée.
- Dans un deuxième temps, les étudiant-es travailleront en deux groupes de 16 sur une vignette clinique ayant pour thème « Que faut-il savoir pour organiser le projet de sortie d'un-e patient-e hospitalisé-e ». L'objectif est d'explorer l'évaluation fonctionnelle dans le cadre d'un projet de sortie en évaluant :
 - 1) les activités de base de la vie quotidienne (bain, habillage, toilettes, transfert, continence, repas),
 - 2) les activités instrumentales de la vie quotidienne (téléphone, courses, préparation repas, ménage, lessive, déplacements, prise de médicaments, gestion des finances),
 - 3) le réseau social.
- Dans un dernier temps, des exemples d'échelles validées et communément utilisées comme l'échelle de Katz pour les AVQ, et celle de Lawton pour les IAVQ seront commentées.

EXAMEN PHYSIQUE GENERAL DE L'ADULTE

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dr. Ido Zamberg, tél. ido.zamberg@unige.ch

Prof. Eduardo Schiffer, tél. 022 382 30 60 ou GSM 32 069

THEME DU SEMINAIRE

- Examen physique général de l'adulte. « Tête-pieds »

OBJECTIFS

- Citer au moins trois situations cliniques dans lesquelles un examen dit « Tête-pieds » est indiqué.
- Pratiquer la réalisation d'un examen physique général de l'adulte.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Par demi-volée et répartition par groupes d'environ 8 étudiants.
- Examen physique entre étudiants sous supervision d'étudiants-moniteurs et de cliniciens.

Veillez vous munir d'une blouse et du matériel nécessaire à l'examen clinique :

Stéthoscope, marteau-réflexe, lampe, diapason.

PRE-REQUIS

Visionner la vidéo de démonstration "Head-to-Toe Examination" :

<https://batesvisualguide.com/multimedia.aspx?categoryID=21787#21768>

Document : [Guide de consultation](#)

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

- Les étudiants se répartissent par groupe de 4 à 8.
- En s'aidant de la check-list mise à disposition et du cahier du séminaire, ils s'exercent à réaliser un examen physique général.
- Chaque groupe est encadré par un étudiant-moniteur.
- A la fin de l'exercice, les étudiants remplissent le résumé de l'examen physique.

MISE EN SITUATION CLINIQUE

PLUSIEURS SITUATIONS CLINIQUES SUGGERANT DE FAÇON PERTINENTE LA REALISATION D'UN EXAMEN TETE-PIEDS :

Situation 1. Vous êtes stagiaire dans un cabinet de médecine interne générale et vous voyez pour la première fois un patient qui a pris rendez-vous pour bilan de santé (« check-up »).

Il s'agit d'un patient de 30 ans en bonne santé habituelle qui a besoin d'un certificat médical afin de postuler pour un nouvel emploi en tant que livreur de colis.

C'est un cas que vous rencontrerez régulièrement en consultation de médecine de premier recours ou en cabinet de médecine interne générale.

Situation 2. Vous êtes stagiaire dans un hôpital universitaire, service de médecine interne générale et vous recevez dans votre unité un patient de 55 ans, connu pour une cirrhose hépatique sur une consommation chronique d'alcool. Le patient présente aussi une consommation active de tabac estimée à 30 UPA. Il se présente aux urgences en raison de l'apparition d'une toux, de myalgies, d'un état fébrile et d'une dyspnée en péjoration depuis 3 jours. Paramètres vitaux : TA 115/80 mmHg, 101 bpm, 38.2°C, 94% de saturation d'O₂ à l'air ambiant.

Vous serez régulièrement exposés à ce type de présentation clinique lors d'une consultation urgente en milieu hospitalier. Cela implique de votre part de focaliser votre anamnèse et votre examen clinique tout en évoquant le diagnostic différentiel d'une dyspnée chez un patient avec plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaires et une maladie hépatique chronique. L'examen clinique tête-pieds vous permettra de passer en revue tous les systèmes concernés par un problème aigu (dyspnée), de manière complète et efficiente, chez un patient porteur de poly morbidité. Votre raisonnement diagnostique devrait évoquer :

- Une IVRS (nécessite un examen ORL et pulmonaire)
- Une bronchopneumonie (nécessite un examen pulmonaire)
- Une décompensation cardiaque (nécessite un examen pulmonaire, cardiaque et vasculaire complet)
- Une décompensation ascitique (qui nécessite aussi un examen neurologique, abdominal et pulmonaire)
- Une maladie thromboembolique (nécessite un examen pulmonaire, cardiaque et vasculaire complet)

Il semble incontournable d'examiner le patient de la tête aux pieds pour pouvoir orienter la suite de la prise en charge (l'origine de la dyspnée peut être multifactorielle).

Situation 3. Toujours dans la même unité de médecine interne générale, vous voyez une patiente de 68 ans hospitalisée pour une bronchopneumonie basale droite. La patiente est connue pour un diabète type II insulino-dépendant, une BPCO, une HTA, une hypercholestérolémie et un tabagisme actif.

Cette présentation clinique est également fréquente tant en pratique de Médecine de premier recours que dans un milieu hospitalier. Un examen clinique de la tête aux pieds vous permettra d'identifier des signes de gravité du syndrome infectieux aigu et d'autres problèmes décompensés qui orienteraient votre prise en charge vers une hospitalisation ou non et vous permettra d'anticiper les complications pendant un éventuel séjour hospitalier chez cette patiente poly morbide.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

Généralités

L'examen physique général de l'adulte, appelé aussi parfois examen « tête-pieds », est un examen organisé et systématique de tous les systèmes d'organes. On le pratique chez la plupart des nouveaux patients ambulatoires et chez tous les patients hospitalisés. Même si cet examen est systématique, il n'est en aucun cas exhaustif : Toute plainte du patient vous dictera quelle partie de l'examen physique vous serez amené à pratiquer de façon plus approfondie.

La coopération du patient est cruciale et tout doit être fait pour le mettre à l'aise. Vous devez veiller attentivement à son confort physique dans un respect constant de sa dignité et de sa pudeur. Assurez-vous d'un environnement qui respecte la confidentialité et qui vous permet de faire un examen physique dans de bonnes conditions en termes de luminosité, de température ambiante et de tranquillité. Le patient doit pouvoir se déshabiller en privé. L'utilisation réfléchie de draps et d'une chemise « hôpital » permet à la fois d'examiner correctement le patient et de respecter sa dignité. Le principe est de découvrir une partie du corps à la fois. Il est important d'indiquer au patient les changements de phase de l'examen afin qu'il puisse les anticiper. Toute manœuvre potentiellement inconfortable doit être expliquée avant d'être pratiquée.

Acquérir une organisation systématique vous aidera à réaliser un examen physique complet et fiable. Avec le temps, vous développerez votre propre manière de faire et vous apprendrez à vous adapter à l'état du patient et au problème clinique.

Un objectif important est de minimiser les changements de position du patient et de vous-même. Veillez à avoir votre matériel d'examen à portée de main.

Voici un schéma d'organisation, parmi d'autres, qui tente de minimiser l'inconfort tout en respectant les besoins d'un examen physique bien conduit.

1) Patient en position assise :

Tête, cou, thorax postérieur, examen neurologique des nerfs crâniens, examen locomoteur et neurologique des membres supérieurs.

Pour un patient affaibli, une grande partie de cet examen peut être pratiquée en position couchée.

2) Patient en position couchée :

Système cardio-vasculaire, abdomen, système urogénital, examen locomoteur et neurologique des membres inférieurs.

3) Patient en position debout :

Examen de la colonne, marche et équilibre.

Il est préférable, même pour les gauchers, de se placer à droite du patient, car cela facilite l'examen de la pression veineuse jugulaire, du cœur et des organes intra-abdominaux.

Dans un système anatomique donné, suivez l'ordre Inspection – Percussion – Palpation - Auscultation, à l'exception de l'examen de l'abdomen où l'auscultation est effectuée avant la percussion ou la palpation, ceci afin de ne pas modifier les bruits intestinaux.

Restez flexible ! Adaptez-vous ! Par exemple, il est généralement préférable de pratiquer une manœuvre inconfortable ou douloureuse en fin d'examen. Le niveau de profondeur de l'examen physique doit être pertinent par rapport au problème clinique. Par exemple, un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral aura besoin d'un examen neurologique très détaillé, ce qui n'est a priori pas le cas d'un patient qui consulte pour une douleur abdominale.

Beaucoup de patients vivent l'examen physique avec une certaine anxiété. Ils se sentent vulnérables et peuvent s'inquiéter d'avoir mal ou de ce que vous pourriez trouver. Ceci requière de vous tact et attention. Au début de votre pratique, vous aurez besoin de plus de temps et il vous faut veiller à ne pas alarmer inutilement le patient. Par exemple, avertissez-le que si vous faites une longue auscultation, cela ne veut pas dire qu'elle est anormale.

Avant l'examen physique, désinfectez-vous les mains et mettez en pratique les principes de précaution primaire. Ajustez la hauteur du lit pour ménager votre dos !

A) PATIENT ASSIS

1. INSPECTION GÉNÉRALE

- Le patient présente-t-il des signes de gravité ?
Tachypnée, battements des ailes du nez, utilisation de la musculature accessoire, agitation, transpiration, pâleur, douleur
- Son aspect correspond-il à son âge biologique ?
- Est-il orienté ? Peut-il collaborer ?
- Quel est son état nutritionnel ?
- Ses téguments ont-ils une coloration particulière ?
Ictère, cyanose, pâleur
- Des signes physiques évocateurs sont-ils immédiatement visibles ?
Facies cushingoïde, exophtalmie, œdèmes

2. SIGNES VITAUX

- Pouls radial palpé simultanément bilatéralement
- Pression artérielle humérale des deux côtés
- Fréquence respiratoire
- Température orale ou rectale.
*Ne pas mesurer la température par voie orale chez un patient agité ou confus.
Eviter les boissons chaudes 20 minutes avec une mesure orale.*

3. PEAU ET PHANERES

- Mains, ongles :
Cyanose, hippocratisme digital, érythrose palmaire, etc.
- Face, nuque, tronc, abdomen, membres supérieurs :
Altération de la couleur des téguments, pilosité, lésions cutanées, nævi, cicatrices.

4. TETE

- Scalp :
 - Inspection du scalp et des cheveux, palpation du scalp
- Face :
 - Palpation des sinus frontaux et maxillaires
 - Sensibilité : branches sensitives de V1, V2 et V3
 - Motricité :
 - V moteur : serrer les dents, mouvements latéraux de la mâchoire inférieure),
 - VII moteur : fermer les yeux, sourire, montrer les dents, gonfler les joues
- Yeux :
 - Inspection des sclères et des conjonctives
 - Inspection avec la lampe de la cornée, de l'iris et du cristallin
 - Acuité visuelle (II) : faire porter les lunettes, carte de Snellen, faire lire un œil à la fois
 - Champs visuels au doigt
 - Mouvements oculaires : Technique du H (III, IV, VI) + convergence
 - Réflexe cornéen V – VII)
 - Réflexes pupillaires direct, indirect et d'accommodation (II, III, parasympathique)
 - Examen du fond d'œil : rétine, n optique (II), vaisseaux sanguins
- Nez :
 - Inspection à l'otoscope si symptômes
- Bouche :
 - Enlever les dentiers, lumière adéquate
 - Inspection langue, dents, gencives, muqueuse buccale, palais dur et mou, amygdales, oropharynx
 - Protrusion langue (XII)
 - Elévation du pharynx et du palais mou (IX et X)
 - Réflexe nauséeux (IX et X)
- Oreilles :
 - Voix chuchotée. Test de Weber et de Rinne avec un diapason 512 Hz
 - Examen à l'otoscope

5. Cou

- Mobilité cervicale : flexion, extension, rotation, latérale
- Résistance à la rotation : sternocléidomastoïdiens (XI)
- Ganglions : occipitaux, auriculaires postérieurs, sous-mandibulaire, cervicaux antérieurs et postérieurs, sus claviculaires
- Palpation thyroïde
- Palpation des glandes parotidiennes
- Localisation de la trachée

6. THORAX POSTÉRIEUR

- Palpation de la colonne vertébrale et de la musculature para spinale
- Inspection et palpation de la cage thoracique postérieure
- Symétrie des mouvements cage thoracique à l'inspiration
- Percussion : identifier les bases pulmonaires, évaluer l'excursion diaphragmatique
- Auscultation pulmonaire
- Transmission vocale si anomalie à la percussion ou à l'auscultation
- Percussion des loges rénales

7. THORAX ANTÉRIEUR

- Seins : chez la femme, inspection bras relâchés, mains levées, mains pressées sur les hanches
- Ganglions : axillaires

8. MEMBRES SUPÉRIEURS

- Examen des téguments
- Ganglions épitrochléens
- Examen locomoteur des mains, des coudes et des épaules
- Examen neurologique :
 - Masses musculaires,
 - Tonus,
 - Force (serrer les doigts, biceps, triceps)
 - Épreuve de barré yeux fermés,
 - Sensibilité : douleur, touché, discrimination touché-piqué, vibrations (Diapason à 128 Hz), sens des positions. Comparer proximal vs distal. Gauche vs droite
 - Réflexes myotatiques : biceps (C5-C6), triceps (C5-C6), stylo radial (C7)
 - Épreuves de coordination : doigt-nez, mouvements rapides des doigts, marionnettes, frapper alternativement.

REMARQUE

Lors d'un examen au lit du malade, comme c'est courant en milieu hospitalier, il n'est pas rare qu'un patient ne puisse pas s'asseoir ou se lever, ce qui impose un changement dans l'organisation de l'examen physique. Il est tout-à-fait possible d'examiner la tête, le cou, le thorax antérieur et les membres supérieurs en position couchée. Aider le patient à se positionner en décubitus latéral pour examiner son dos et ausculter ses poumons.

B) PATIENT COUCHE

9. THORAX ANTÉRIEUR

- Inspection, palpation grill costal
- Auscultation pulmonaire antérieure
- Système cardiovasculaire
 - Pouls jugulaire, estimation de la pression veineuse jugulaire, recherche d'un reflux hépato jugulaire
 - Palpation et auscultation des carotides l'une après l'autre, jamais simultanément
 - Inspection et palpation du précordium (thrill)
 - Palpation du choc de pointe, recherche d'un choc D
 - Auscultation cardiaque aux 5 foyers en position couchée. Auscultation de l'apex en décubitus latéral G et du foyer aortique en position assise.
- Palpation des seins chez l'homme et la femme

10. ABDOMEN

- Inspection et auscultation de l'abdomen dans les 4 quadrants
- Percussion dans les 4 quadrants avec mesure de la flèche hépatique
- Palpation superficielle et profonde des 4 quadrants, palpation du bord inférieur du foie
- Palpation et auscultation de l'aorte abdominale et des artères rénales
- Palpation de la rate et des reins
- Touché rectal : *cet examen est souvent pratiqué à la fin de l'examen physique*

11. ORGANES GÉNITAUX EXTERNES ET PÉRINÉE

- Examen des organes génitaux externes. Recherche d'une hernie inguinale

12. MEMBRES INFÉRIEURS

- Inspection de la peau et des phanères : œdème anomalies trophiques, ulcères, œdèmes, etc.
- Système vasculaire périphérique :
 - Palpation et auscultation des a. fémorales, palpation des a. poplitées, tibiales post et pédieuses
 - Palpation des ganglions inguinaux
- Système locomoteur :
 - Inspection des articulations. Si nécessaire, examen articulaire spécifique

- Examen neurologique :
 - Masses musculaires,
 - Tonus,
 - Force (flexion de la hanche = ilio-psoas, extension du genou = quadriceps, extension de hanche = grand fessier, dorsiflexion du pied = jambier antérieur, flexion plantaire du pied = jumeau)
 - Épreuve de Mingazzini
 - Sensibilité : douleur, touché, discrimination touché-piqué, vibrations (diapason à 128 Hz), sens des positions. Comparer proximal vs distal, gauche vs droite
 - Réflexes myotatiques : rotulien (L2,L3,L4) et achilléen (S1-S2)
 - Épreuves de coordination : talon-genou
 - Réflexe cutané plantaire (Babinski)

C) PATIENT DEBOUT

- Système cardiovasculaire
 - Recherche de varices
- Système locomoteur,
 - Alignement de la colonne vertébrale, équilibre du bassin, alignement des membres inférieurs
- Chez l'homme l'examen du pénis, du scrotum et des testicules se pratique mieux en position debout de même que la recherche d'une hernie inguinale
- Système neurologique
 - Marche normale, marche talon-pointe, demi-tour, épreuve du funambule, Romberg yeux ouverts puis fermés

ANALYSE DES GAZ SANGUINS

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire
Dr Raphaël GIRAUD, PD-CC

Tél. 022 372 74 78
Tél. 079 553 21 96

THEME DU SEMINAIRE

Analyses systématiques de gazométries artérielles (et veineuses) mélangées à l'aide d'exemple cliniques commentés.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Groupes d'env. 9 étudiants

TRANSFUSIONS SANGUINES

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire

Dr Sophie Waldvogel Abramowski – tél. 079 553 47 60

Remplaçant

Dre Caroline Stephan

METHODE D'ENSEIGNEMENT

Par demi-volée

OBJECTIFS DU SEMINAIRE

- Connaître les aspects légaux et normatifs qui régissent la transfusion.
- Connaître les éléments de base de la qualification biologique des donneurs de sang et des produits.
- Connaître la composition des différents produits sanguins labiles disponibles :
 - Concentrés érythrocytaires
 - Concentrés plaquettaires
 - Plasmas frais congelés
 - Autres (cellules souches hématopoïétiques, lymphocytes, granulocytes)
- Connaître les indications cliniques à l'administration des différents produits sanguins
- Connaître les transformations et qualifications particulières pour les produits sanguins :
 - Irradiation
 - Inactivation
 - Lavage/déplasmatisation
 - Fractionnement du plasma
 - Immunité érythrocytaire et test de compatibilité majeur
 - Immunité leuco-plaquettaire (HLA ou HPA)
 - Sérologie CMV

- Savoir comment prescrire un produit sanguin labile :
 - Information au patient/ consentement
 - Prescription médicale

- Connaître les éléments critiques de la procédure transfusionnelle :
 - Conditions pré-analytiques
 - Analyses pré-transfusionnelles
 - Contrôle ultime au lit du malade
 - Surveillance péri- et post-transfusionnelle

- Connaître les paramètres permettant de juger de l'efficacité d'une transfusion
- Connaître les principaux effets secondaires de la transfusion
- Connaître la procédure d'hémovigilance (patient et donneur)

LABORATOIRE 4

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Prof. Nicolas Vuilleumier, tél. 022 / (37) 27 355

THEME DU SEMINAIRE

Laboratoire : Prescriptions d'analyses de laboratoire

METHODE D'ENSEIGNEMENT

Par demi-volée

OBJECTIFS

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s qui s'apprêtent à effectuer des stages cliniques et les prépare à la pratique hospitalière et de cabinet.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plusieurs volets seront abordés, comprenant des aspects scientifiques, rationnels et humains. Les domaines pré et post-analytiques seront revus dans les grandes lignes.

Des exercices pratiques tirés d'expérience hospitalière montreront les effets d'une sur-prescription ou d'une prescription inadéquate.

Des informations sur les principes d'interprétation des résultats des tests d'analyses biomédicales et de leurs conséquences sur la prescription de ces mêmes analyses, seront communiquées aux étudiant-e-s.

COMMUNICATION EN MILIEU CLINIQUE 9

« Annonce d'une mauvaise nouvelle »

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Dre Noëlle Junod, Programme de compétences en supervision et encadrement (PCSE), HUG
022 372 96 76 /079 55 33 712

Assistante administrative pour l'enseignement :

Mme Adriana Costantino, Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfance – luMFE
Centre Médical Universitaire
Tél : +41 22 379 57 14, Absente le lundi et mercredi

OBJECTIFS

- Reconnaître les situations d'annonce de mauvaise nouvelle
- Identifier et mettre en pratique des stratégies/outils de communications utiles pour annoncer une mauvaise nouvelle

MÉTHODE

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiant-es.
- Travail en groupe
- Entretien avec un-e patient-e standardisé-e supervisé par un-e tuteur/trice

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

PREMIERE PARTIE

Cette partie doit permettre aux étudiant-es reconnaître la variété des situations d'annonce de mauvaise nouvelle auxquels les médecins sont régulièrement confrontés et d'en connaître les implications à la fois pour le/la patient-e et le/la médecin.

DEUXIEME PARTIE

L'observation de séquences de consultations filmées va permettre aux étudiant-es d'identifier les stratégies/outils de communication utiles et moins utiles à l'annonce d'une mauvaise nouvelle.

TROISIEME PARTIE

Dans la dernière partie, les étudiant-es vont exercer ces stratégies/outils de communication à tour de rôle avec un-e patient-e acteur/trice sous la supervision du/de la tuteur/trice.

Références et lectures recommandées :

<https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=7647§ion=9>

COMMUNICATION EN MILIEU CLINIQUE 10

« Mener un entretien avec un.e adolescent-e / jeune adulte »

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Dr Pawan Prasad, Institut universitaire de Médecine de Famille et de l'Enfant,
Faculté de médecine
tél. 022 / 379 50 84

Assistante administrative:

Mme Adriana Costantino - adriana.costantino@unige.ch

Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfance - luMFE, Tél : +41 22 379 57 14, Absente le lundi et mercredi, CMU bureau A03.3016a

THEME DU SEMINAIRE

- Spécificités de l'entretien avec un-e patient-e jeune (selon définition OMS 12-25 ans). Ce séminaire fait suite aux cours pédiatriques et se focalise sur les problématiques des adolescent-es plus âgés-es et des jeunes adultes.
- Lien avec les cours :
 - MFE (prévention chez les jeunes) 1^{ère} année
 - Consultation médicale (2^{ème} année) et Communication en milieu clinique (CMC 1-9 : 2^{ème} et 3^{ème} année)
 - Séminaires et cours pédiatriques : anamnèse de l'adolescent-e, développement et rôle des parents.

OBJECTIFS GENERAUX

- Créer des conditions favorables à l'établissement d'une alliance avec un-e patient-e jeune.
- Savoir identifier les spécificités d'un entretien avec un-e patient-e jeune (étapes de développement, place de la famille, épidémiologie et besoins de santé).
- Savoir évaluer une situation à risque pour la santé en identifiant les risques et les ressources dans une approche de santé globale

METHODE

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 15 étudiant-es.
- **Exercices pratiques en groupe, mise en situation avec un-e patient-e simulé-**

e.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Dans les entretiens avec un.e patient.e jeune (selon définition OMS 12-25 ans)

- Déterminer les spécificités du cadre de l'entretien (comparé à un entretien avec des adultes)
- Créer des conditions favorables à l'établissement d'une alliance
- Explorer les habitudes de vie et l'anamnèse psychosociale des jeunes en utilisant le HEADSSS guide d'entretien structuré pour l'anamnèse psychosociale)
- Prendre en compte ses propres attitudes et leur impact sur la relation avec le/la patient.e
- Savoir s'adapter aux patient.es proche en âge

SITUATION (EXEMPLES)

- **Claude**, 21 ans, aime les sports de glisse, ne cache pas fumer du cannabis, consulte souvent pour des entorses ou des contusions...
- **Isabelle**, 18 ans, a souvent mal à la tête...
- **Jonathan**, 16 ans, vient pour un certificat d'apprentissage

Références et lectures recommandées :

- Parisi V, et al. Apport du guide d'entretien HEADSSS dans l'apprentissage de la démarche diagnostique avec un adolescent : Perspectives d'étudiants lors de cours à option interprofessionnels *Rev Med Suisse* 2017 ; 13 : 996-1000
- Meynard A et al. Du pédiatre au généraliste : apporter une continuité aux soins de premier recours de l'enfance à l'âge adulte. *Rev Med Suisse* 2018 ; 14 : 966-70
- Doukrou M, Segal TY. Fifteen-minute consultation: Communicating with young people—how to use HEEADSSS, a psychosocial interview for adolescents. *Arch Dis Child Educ Pract Ed* 2018;**103**:15–19. doi:10.1136
- Checklist pour les examens de prévention recommandés par la Société Suisse de Pédiatrie 2011 Swiss Society of Pediatrics

http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/membres/checklists/pdf/checklisten_201204_f_office.pdf

- Tous les deux ans Numéro spécial de la Revue médicale suisse sur la Santé des adolescents.

FACULTÉ DE MÉDECINE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE DE FAMILLE ET DE L'ENFANCE

 UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Guide d'entretien pour l'anamnèse psychosociale (Adolescent.e. & Jeune Adulte)

H.E.A.D.S.S.S

Habitat (logement, situation familiale)

Education (scolarité : apprentissages , relations , sociales , travail)

Activités / **A**limentation (sports et activités de loisirs/ habitudes alimentaires, image, estime de soi)

Drogues (usage et mésusage : tabac, alcool, drogues, médicaments)

Sexualité (identité, orientation, attentes, comportements)

Stress / **S**anté mentale / **S**uicide (humeur, anxiété, dépression, conduites suicidaires)

Sécurité (prises de risque, prévention des accidents)

La **CONFIDENTIALITÉ** doit être abordée lors de chaque entretien avec un.e adolescent.e et sa famille, y compris les autres intervenant.e.s du réseau (éducateur.rice.s, assistant.e.s sociaux.ales,...).

La question du **TU / VOUS** doit être également soulevée.

Adapté de Goldenring, J.M., Getting into adolescent heads: An essential update. Contemporary Pediatrics, 2004(21): p.64

Institut de médecine de famille et de l'enfance, Faculté de médecine, UNIGE, Unité santé Jeunes, Département de l'enfant et de l'adolescent et Département de médecine communautaire et de premier recours HUG

 HUG
Hôpitaux
Universitaires
Genève

H.E.A.D.S.S.S

Quelques exemples pour débiter, votre style sera toujours plus naturel.
Utiliser des questions ouvertes, adaptées au stade de développement.

Habitat (logement, situation familiale)

- Ou habitez-vous, avec qui ?...

Education (scolarité ; travail)

- Quels sont vos points forts à l'école ?

- Comment cela se passe-t-il à l'école/ au travail ?

Activités (sports et activités de loisirs)

- Qu'aimez-vous faire de votre temps libre ?

- Quelles séries regardez-vous ?

- Avez-vous déjà vécu des choses difficiles sur internet ou les réseaux sociaux ? Si oui, à qui en parlez-vous ?

Alimentation (habitudes alimentaires/ image, estime de soi)

- Beaucoup de jeunes sont préoccupé.e.s par leur poids. Comment vous trouvez-vous ?

Drogues (usage et mésusage : tabac, alcool, drogues, médicaments)

- Beaucoup de jeunes essaient l'alcool, les cigarettes, des drogues. Est-ce que vos ami.e.s ou vous avez déjà essayé.e.s ?

Sexualité (identité, orientation, attentes, comportements)

- Il peut arriver de naître dans un corps de garçon et se sentir fille ou le contraire, qu'en est-il pour vous ?

- Avez-vous déjà été amoureux.se ?

- On peut être attiré par les filles, par les garçons, par les deux : qu'en pensez-vous ?

Stress / Santé mentale / Suicide (humeur, anxiété, dépression, conduites suicidaires)

- Comment décririez-vous votre moral ces temps ?

- Y-a-t-il eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti.e très triste ?

- Avez-vous eu envie de mourir / de vous faire du mal ?

Sécurité (prises de risque, prévention des accidents)

- Comment rentrez-vous chez vous après une soirée ?

- Comment vous rendez-vous à l'école, au travail ?

Mise à jour Juin 2023

L'entretien avec un jeune (12-25 ans) Grille d'observation des compétences en communication	
Au début de l'entretien avec un adolescent seul /en présence d'un adulte/pair,... le soignant/étudiant	
Se présente ainsi que le dispositif de soin	
Clarifie le contexte (qui a pris le rdv: parents, autres adultes, l'adolescent et pourquoi ; facturation et aspects financiers,...)	
Informe sur la durée et le déroulement de l'entretien (programme)	
Débute l'entretien avec une question ouverte	
Si le début de l'entretien se fait en présence d'un adulte, la confidentialité et ses limites sera abordée en présence de l'adulte puis rappelée avec l'adolescent seul	
Précisera les noms et fonctions des divers intervenants et expliquera les règles de confidentialité et de communication avec la famille et au sein du réseau (ex : parents, santé scolaire, services sociaux, autres professionnels de santé,...)	
Au cours de l'entretien le soignant/l'étudiant	
Se concentre d'abord sur le motif de consultation	
Informe le patient qu'il a le droit de ne pas répondre à toutes les questions	
Aborde la confidentialité et ses limites en donnant des exemples concrets	
Demande au patient s'il a d'autres questions et donne des exemples <u>concrets</u> (ex : peur d'une grossesse, prise de risque, besoin d'un certificat,...)	
Demande l'accord pour aborder les sujets intimes et ne les aborde pas en premier lieu	
Est attentif au rythme de l'entretien (trop rapide, trop lent,..) et laisse du temps pour répondre	
Utilise les reflets (verbaliser les émotions, s'ajuster, montrer ce qu'on a compris,...)	
A une attitude non-jugeante (éviter le rôle de parent, éviter le rôle de « copain »)	
Parle de façon claire avec des mots simples en évitant le jargon médical et le langage infantilisant : s'adapter au stade de développement	
Utilise l'examen physique (ex :poids, taille, stades de Tanner..) comme support pour aborder les questions d'image de soi / de représentations du corps/ de croissance et de puberté, de normalité,....	
Evalue la capacité de discernement pour un sujet donné en encourageant la réflexion et l'expression avec des exemples de la vie quotidienne	
A la fin de l'entretien le soignant/étudiant d'abord avec l'adolescent seul puis avec les parents/adultes	
Résume la situation et s'assure que le patient a compris (demander de reformuler,..)	
Demande au patient s'il a d'autres questions	
Explique clairement ce qui va être fait par la suite	
Clarifie avec le patient ce qui peut ou non rester confidentiel, ce qui devrait être discuté avec les intervenants du réseau	
Clarifie le rôle des intervenants du réseau (par ex : santé scolaire, services sociaux, parent, autres professionnels de santé,...) et les règles de communication pour la situation actuelle	

EXAMEN BUCCO-DENTAIRE

Responsables du séminaire

Dr G. De Maria

Dr A. Rabufetti

THEME DU SEMINAIRE

Apprendre à réaliser systématiquement un examen bucco-dentaire.

OBJECTIFS

Intégrer l'examen bucco-dentaire dans l'examen clinique.

Se familiariser avec les principales affections bucco-dentaires d'origine locale ou générale.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Connaître l'anatomie topographique de la cavité buccale et les différents aspects de la muqueuse buccale normale.
- Apprendre la technique de réalisation d'un examen bucco-dentaire.
- Savoir évaluer l'hygiène et l'état bucco-dentaire.

FORMAT D'ENSEIGNEMENT : MISE EN SITUATION AVEC DES PATIENTS

- Sessions de 2h, groupes d'env. 9 étudiants
- Présentation orale
- Illustration de quelques affections bucco-dentaires par des diapositives
- Démonstration pratique

Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 13th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021. WB 205 1

EXAMEN ORL DE BASE

PERSONNE CONCERNÉE

Responsable du séminaire

Dr Cédric Gillabert, Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, tél. 022 7090295,
e-mail : c.gillabert@unige.ch

THEME DU SEMINAIRE

Examen ORL de base en médecine de premier recours

OBJECTIFS DU SEMINAIRE

- Rappeler l'anatomie de la sphère ORL (oreilles; nez et sinus; cavité buccale; région latéro-cervicale)
- Enseigner aux étudiants les principaux signes et symptômes de la sphère ORL
- Découvrir et manier l'otoscope monoculaire et le diapason
- Apprendre l'examen clinique ORL de base :
 - examen de la face et de la région cervicale
 - examen de la cavité buccale et de l'oro-pharynx
 - examen du nez
 - examen du CAE et du tympan avec l'otoscope
 - acoumétrie clinique (Rinne et Weber)

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Groupes d'environ 12 étudiants
- Rappel sémiologique et anatomique, présentation des instruments
- Démonstration de l'examen ORL de base par un médecin de premier recours en pratique libérale (interniste-généraliste ou pédiatre)
- Exercices des étudiants entre eux par groupe de 2. Supervision par le médecin
- Matériel: 5 otoscopes à disposition par groupe/abaisses-langues/diapasons

Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 13th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021. WB 205 1

URGENCES : REFRESH REANIMATION

PERSONNES CONCERNÉES

Responsable du séminaire

Dr Birgit Gartner / HUG – tél. 079 / 553 47 32

Secrétariat

Mme Uyen Vetter – tél 022 / 372 81 05

THÈME DU SÉMINAIRE

- « Refresher course » de Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) : Basic Life Support (BLS) – Automated External Defibrillation (AED)

OBJECTIFS

- Tout.e étudiant.e en médecine doit pouvoir initier et réaliser correctement une séquence de RCP complète selon le concept BLS-AED pour les non-professionnel.le.s avant de débiter les stages en milieu clinique.
- Cet atelier s'insère dans le programme d'apprentissage longitudinal des gestes techniques et d'urgences. Son but est de permettre aux étudiant.e.s de pratiquer les gestes de soins immédiats en réanimation une troisième fois sur un mannequin avant de débiter les stages en milieu clinique. Il se base donc sur les objectifs des séminaires CC Réanimation 1&2 :
 - Appliquer correctement les étapes d'une réanimation cardio-pulmonaire de base :
 - Identification de l'ACR (critères diagnostics)
 - Respect de la séquence d'alarme
 - Application des compressions thoraciques conformes au CosTR (Consensus on Science with Treatment Recommendations) de l'ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation)
 - Ventilation au masque facial et Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle (BAVU)
 - Emploi du Défibrillateur Semi-Automatique (DSA = AED - Automated External Defibrillator)
- Tou.te.s les étudiant.e.s seront amené.e.s à exercer la séquence complète au moins une fois, seul.e.s ou à deux

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 45 minutes par groupe de 8 étudiant.e.s

DÉROULEMENT ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU SÉMINAIRE

- **Il est recommandé de refaire le module e-learning « CC Réanimation » disponible sur Moodle avant d'entreprendre le séminaire**
- Rappel théorique limité au strict minimum, le but de l'atelier étant la pratique de la séquence de réanimation par tou.te.s les étudiant.e.s.
- Tou.te.s les étudiant.e.s pratiquent au moins une fois la séquence complète
 - Les scénarii peuvent être variés par l'enseignant.e
 - En fonction du scénario choisi, les étudiant.e.s travaillent seul.e.s ou en équipe
 - Favoriser l'observation et le feedback entre étudiant.e.s (sur la base de la checklist/grille d'évaluation)

POUR EN SAVOIR PLUS :

<https://www.resuscitation.ch/fr/> - Site internet du Swiss Resuscitation Council
<https://cprguidelines.eu/> - Guidelines de réanimation du European Resuscitation Council (ERC)
<https://eccguidelines.heart.org/> - Guidelines de réanimation de l'American Heart Association (AHA)
<http://www.ilcor.org> - International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)

RADIOLOGIE

« Lecture d'une image radiologique conventionnelle du thorax »

PERSONNES CONCERNEES

RESPONSABLE DU SEMINAIRE
Prof. Minerva Becker, Service de radiologie
Tél : 022 372 70 56

Secrétariat enseignement :
Mme Zoé Allisson 022 372 70 56

THEME DU SEMINAIRE

Approche pratique à l'interprétation des radiographies standard du thorax.

OBJECTIFS

Connaître le principe de l'analyse de la radiographie du thorax.

Savoir reconnaître les structures anatomiques normales sur les radiographies du thorax.

Savoir reconnaître l'aspect radiologique des pathologies suivantes : pneumonie, épanchement pleural, insuffisance cardiaque gauche, masse médiastinale et masse pulmonaire.

Favoriser l'observation et le feedback entre les étudiants sur la base d'une check – list et d'une participation active dans le cadre du séminaire

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h avec un collectif d'env. 20 étudiant-e-s
- Application pratique des notions abordées dans le cours UIDC Rx 1 et Rx 2
- Cas cliniques démonstratifs avec analyse interactive

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Le-a formateur-riche s'assurera, en premier lieu, que les étudiant-e-s connaissent les notions abordées dans le cours UIDC Rx 1 et Rx 2 et procédera à un bref rappel des notions de base à utiliser dans l'analyse systématique des clichés conventionnels.

Les étudiant-e-s procéderont ensuite à l'analyse systématique de cas cliniques démonstratifs et présenteront leurs cas aux autres étudiant-e-s.

Le-a formateur-riche s'assurera que le séminaire se déroule de manière interactive. L'accent est mis sur l'identification des structures normales et pathologiques et sur l'utilisation appropriée de la terminologie correcte.

RADIOLOGIE

« Approche interactive à l'imagerie de l'abdomen aigu »

PERSONNES CONCERNEES

RESPONSABLE DU SEMINAIRE :

Prof. Minerva Becker, Service de radiologie
Tél : 022 372 70 56

Secrétariat enseignement :
Mme Zoé Allisson 022 372 70 56

THEME DU SEMINAIRE

Imagerie de l'abdomen aigu

OBJECTIFS

Comprendre le rôle des différents examens radiologiques dans le contexte de l'abdomen aigu non-traumatique notamment les points forts et les inconvénients des différentes méthodes d'imagerie (radiographie, échographie, CT, IRM) dans le contexte des pathologies présentées lors du séminaire.

Savoir reconnaître les structures anatomiques normales sur les examens radiologiques présentés.

Comprendre l'aspect radiologique typique des pathologies suivantes : l'appendicite, la cholécystite, la cholédocholithiase, l'obstruction intestinale, la perforation intestinale, la pancréatite.

Favoriser l'observation et le feedback entre les étudiant-e-s sur la base d'une check – list et d'une participation active dans le cadre du séminaire.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h avec un collectif d'env. 20 étudiant-e-s.
- Introduction théorique et application pratique des notions abordées dans l'introduction.
- Cas cliniques démonstratifs avec analyse interactive.

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Le-a formateur-ricer procèdera, dans un premier temps, à une présentation des différents examens radiologiques utilisés dans le contexte de l'abdomen aigu non-traumatique et des notions de base facilitant l'analyse systématique des pathologies présentées dans le séminaire.

Les étudiant-e-s procéderont ensuite à l'analyse systématique de cas cliniques démonstratifs et présenteront leurs cas aux autres étudiant-e-s.

Le-a formateur-ricer s'assurera que le séminaire se déroule de manière interactive. L'accent est mis sur l'identification des structures normales et pathologiques et sur l'utilisation appropriée de la terminologie correcte.

RADIOLOGIE

« Lecture d'une image radiologique conventionnelle en ostéoarticulaire »

PERSONNES CONCERNEES

RESPONSABLE DU SEMINAIRE

Prof. Minerva Becker, Service de radiologie

Tél : 022 372 70 56

Secrétariat enseignement :

Mme Zoé Allisson 022 372 70 56

THEME DU SEMINAIRE

Approche pratique à l'interprétation des radiographies standard ostéo-articulaires.

OBJECTIFS

Connaître le principe de l'analyse des radiographies ostéo-articulaires.

Savoir reconnaître les structures anatomiques normales sur les radiographies du bassin, de la colonne, des pieds et des mains.

Savoir reconnaître l'aspect radiologique des pathologies suivantes : fracture/tassement, arthrose, métastase.

Favoriser l'observation et le feedback entre les étudiants sur la base d'une check – list et d'une participation active dans le cadre du séminaire.

A l'issue de ce cours, l'étudiant aura également vu des exemples typiques de polyarthrite rhumatoïde, goutte, maladie de Bechterew ainsi que de spondylite et ostéomyélite.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h avec un collectif d'env. 20 étudiant-e-s
- Application pratique des notions abordées dans le cours UIDC Rx 3
- Cas cliniques démonstratifs avec analyse interactive

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Le-a formateur-riche s'assurera, en premier lieu, que les étudiant-e-s connaissent les notions abordées dans le cours UIDC Rx 3 et procédera à un bref rappel des notions de base à utiliser dans l'analyse systématique des clichés conventionnels.

Les étudiant-e-s procéderont ensuite à l'analyse systématique de cas cliniques démonstratifs et présenteront leurs cas aux autres étudiant-e-s.

Le-a formateur-riche s'assurera que le séminaire se déroule de manière interactive. L'accent est mis sur l'identification des structures normales et pathologiques et sur l'utilisation appropriée de la terminologie correcte.

COURS SUTURA

PERSONNE CONCERNEE

Tuteur : Dr Arnaud Dupuis 079 553 47 08

Préparateur : SWISS Foundation for Innovation and training in Surgery (022 322 9100)

THEME DU SEMINAIRE

Introduction aux sutures

OBJECTIFS

1. Introduction aux Instruments chirurgicaux
2. Introduction aux types de fils et aiguilles
3. Techniques de suture
 - a. Points séparés
 - i. Simples
 - ii. Donati
 - iii. Algöwer
 - b. Surjets
 - i. Simple
 - ii. Passé
 - iii. Intradermique

METHODE D'ENSEIGNEMENT

Pratique, sur pied de porc

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

SFITS

3h30 de cours y compris 15 min de pause

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Acquérir les connaissances nécessaires concernant les instruments, les fils et aiguilles ainsi que de la technique afin d'être en mesure d'effectuer une suture cutanée.

SECTION DC

DIMENSIONS COMMUNAUTAIRES

Séminaires interactifs

QUALITES DES SOINS

DEUX SÉMINAIRES INTERACTIFS

OBJECTIF

Comprendre les approches actuelles et les enjeux de la gestion et de l'amélioration de la qualité des soins, en particulier les aspects qui concernent les médecins cliniciens

QUALITE DES SOINS 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Dr Aimad Ourahmoune, tél. 022 / (37) 29 012

THEME DU SEMINAIRE : QUALITE ET SECURITE DES SOINS : ETAT DES LIEUX ET ENJEUX

- Groupes d'environ 30 étudiant·e·s
- Fondamentaux de la qualité et de la sécurité des soins

OBJECTIFS

Présentation du cycle de séminaires « Qualité et sécurité des soins »

Définir ce que sont la qualité et la sécurité des soins

Comprendre le caractère multidimensionnel de la qualité

Comprendre les enjeux concernant la qualité et la sécurité des soins

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Exposé interactif
- Exercices et discussions

DEROULEMENT DE LA SESSION

Déroulement : lecture d'une vignette illustrant une problématique et débat en groupe

LECTURE AVANT COURS (sur le site de l'Unité)

- Garnerin P, Bovier P, Chamot E, Chastonay P, Chopard P, Herrmann F, Perneger T. **Qualité des soins**. Bulletin médecins suisses 2001;82;2020-4.

LECTURE ASSOCIEE AU SEMINAIRE (sur le site de l'Unité)

- Berwick D. **Avoiding overuse, the next quality frontier**. Lancet 2017;390:102-104
- Brownlee S et al. **Evidence for overuse of medical services around the world**. Lancet 2017;390:156-68
- Mc Glynn EA, Asch SM, Adams J, et al. **The Quality of Health Care Delivered to Adults in the United States**. June 26, 2003;348(26):2635-2645.
- Vincent C, Taylor-Adams S et al. **Comment enquêter sur des incidents cliniques et les analyser: protocole de l'unité des risques cliniques et de l'association de la gestion du contentieux et des risques**. Ann Fr Anesth Réanim 2002 ; 21 : 509.16.
- Berwick DM. A Primer on Leading the Improvement of Systems. British Medical Journal. 1996;312:619-622.

QUALITE DES SOINS 2

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Dr Aimad Ourahmoune, tél. 022 / (37) 29 012

THEME DU SEMINAIRE

Processus de soins et mesure

OBJECTIFS

Définir ce qu'est un processus clinique

Etre capable de modéliser un processus simple

Comprendre les principes de variance associée à un processus clinique

Comprendre l'avantage des run chart Vs données agrégés (étude avant-après)

Mesurer la variance d'un processus à l'aide d'une run chart

Savoir interpréter les résultats d'une run chart

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Groupes d'env. 30 étudiant·e·s
- Exercices et discussions

DEROULEMENT DE LA SESSION

Les étudiants devront mettre en pratique les notions apportées dans les lectures et diaporama envoyés avant le cours, dans des cas pratiques en groupe.

LECTURE AVANT LE SEMINAIRE (sur le site de l'Unité)

PERLA RJ, PROVOST LP, MURRAY SK. **THE RUN CHART: A SIMPLE ANALYTICAL TOOL FOR LEARNING FROM VARIATION IN HEALTHCARE PROCESSES.** BMJ QUAL SAF 2011;20: 46-51

LECTURE ASSOCIEE AU SEMINAIRE (sur le site de l'Unité)

Décrire et Analyser un processus de prise en charge MEAH Hôpital 2007

Berwick D, James B Coye M, **Connections Between Quality Measurement and Improvement**, Medical Care; Vol 41, N°1, Suppl, pp I-30-I-38

MEDECINE ET SOINS PALLIATIFS

PERSONNE CONCERNEE

Responsables du séminaire

Pre Sophie Pautex, tél. 022 / 305 75 10

Pre Monica Escher, tél. 022 / 372 29 23

THEME DU SEMINAIRE

Identification des différents aspects d'une prise en charge en soins palliatifs

OBJECTIFS

A l'issue de ce séminaire, les étudiant-es devront être capables de:

- Enoncer les principaux objectifs de la médecine palliative, en particulier l'importance de son introduction précoce
- Identifier les patient-es en situation palliative
- Reconnaître l'importance du réseau spécialisé de soins palliatifs
- Identifier les rôles des différent-es professionnel-les
- Identifier le rôle et les besoins des proches
- Accepter et comprendre ses propres émotions

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Groupes d'environ 18 étudiant-es.
- Projection d'un film qui illustre les différents éléments des soins palliatifs
- Discussion interprofessionnelle avec un-e médecin et un infirmier ou une infirmière spécialisé-es en médecine palliative

MEDECINE LEGALE ET ETHIQUE 1 : " Prise de décision et capacité de discernement "

PERSONNES CONCERNEES

Responsables : Pre B. Elger (Tél : 37 95 589), Pre S. Grabherr (Tél : 37 95 594) et Pre S. Hurst (Tél : 37 94 601)

THEME

Prise de décision et capacité de discernement

OBJECTIFS

1. Connaissance des notions de consentement libre et éclairé y compris la notion de capacité de discernement
2. Connaissance de la procédure de décision concernant les patient-es incapables de discernement
 - Directives anticipées
 - Connaissance de la personne qui prendra la décision pour le/la patient-e (médecin, proches, représentant-e thérapeutique ou représentant-e légal, s'il/elle existe et s'il/elle est présent-e)
 - Présentation succincte des mesures de protection de l'adulte
3. Connaissance de la procédure de décision en situation d'urgence

METHODE D'ENSEIGNEMENT

Cours ex cathedra

Nombre d'étudiant-es : volée entière

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

La première partie du cours, sera consacrée à la présentation des aspects légaux et éthiques de la prise de décision pour un/une patient-e capable et incapable de discernement.

La deuxième partie du cours illustrera, par un jeu de rôle entre une médecin clinicienne et un patient simulé, la mise en œuvre en clinique des concepts et connaissances présentés dans la première partie.

LECTURES ASSOCIEES AU SEMINAIRE:

- Manaï D. **Le devoir d'information** (p. 255-264) ; Dumoulin J.-F. **Consentement libre et éclairé et refus de soins** (p. 265-280) ; Martin-Achard P. et Hochmann Favre M. **Incapacité de discernement et soins** (p. 281-288) ; Guillod O. Mandofia Berney M. **Le mineur face au traitement proposé** (p. 289- 294) ; **Testament et mesures personnelles anticipées dans le domaine médical** (p. 295-306) ; Manaï D. **Le droit des proches dans la décision médicale** (p. 307- 316) ; Restellini J.-P. et coll. **Traitement en situation d'urgence** (p. 317-326). In Droit de la santé et médecine légale. Genève : Médecine et Hygiène 2014.
 - Guillod O. avec la collaboration de Erard F. **Droit médical. Chapitre 8 Le choix libre et éclairé des soins**. Bâle, Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn. 2020. p.287 ss
 - Hochmann Favre M., Martin-Achard P. **Le médecin et le patient incapable de discernement**. Quels changements apporte le nouveau droit de la protection de l'adulte? Revue Médicale Suisse 2013;9:1791-1793.
 - Pally Hofmann. **Mon patient est-il capable de discernement ?** Bulletin des médecins suisses 2019;100(34):1102-1103.
 - Académie suisse des sciences médicales ASSM
Directives médico-éthiques :
 - **La capacité de discernement dans la pratique médicale** (2019)
 - **Prise en charge et traitement des personnes atteintes de démence** (2017)
 - **Directives anticipées** 2009 (mise à jour 2013) ;
 - **Décisions de réanimation** 2008 (mise à jour 2013) ;
 - **Mesures de soins intensifs** 2013 (**Directives «Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources»** insérées en 2020 et 2021
 - **Mesures de contrainte en médecine** 2015
 - Dispositions légales:
 - Code civil suisse, art. 11-19c et 370 ss.
 - Dispositions cantonales:
- Loi genevoise sur la santé et patients (K.1.03), en particulier art. 45-49.

MÉDECINE LÉGALE 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Prof Silke Grabherr

Prof Tony Fracasso

THEMES DU SEMINAIRE

La vitalité

Classification des causes de décès : la mort naturelle et la mort violente

La mort subite de l'adulte et du nourrisson

Lésions par mécanisme contondant, tranchant et piquant

OBJECTIFS

- Se familiariser avec la notion de vitalité et son importance en médecine légale
- Apprendre à faire la distinction entre « mort naturelle » et « mort violente ».
- Parmi les morts naturelles, se familiariser avec la notion de « mort subite » de l'adulte et du nourrisson.
- Parmi les morts violentes, se familiariser avec les morts violentes d'origine traumatique par agent vulnérant (contondant, tranchant, piquant)

Catalogue suisse des objectifs

C FM

4, 5, 6, 7, 8, 9

10, 11, 12, 13

23, 24, 25

45, 46

52, 57, 58, 59, 60

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Cours ex-cathedra.
- Demi-volée

POUR EN SAVOIR PLUS:

Handbook of forensic medicine

Burkhard Madea, Wiley & Sons, Incorporated, John

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119648628>

ISBN: 9781119648550 2022

Droit de la santé et médecine légale

Romano La Harpe, Marinette Ummel, Jean François Dumoulin

<https://www.revmed.ch/livres/droit-de-la-sante-et-medecine-legale>

ISBN 9782880494759 2014

Médecin et droit médical

BERTRAND Dominique UMMEL Marinette DUMOULIN Jean-François

Institut Universitaire de Médecine Légale

[Médecine et Hygiène](#) 3^{ème} édition 2009

MÉDECINE LÉGALE 4

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire :

Prof Silke Grabherr

Prof Tony Fracasso

THEME DU SEMINAIRE

Plaie par arme à feu

Asphyxies (1) (Classification et physiopathologie)

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître les lésions par arme à feu ainsi que les mécanismes lésionnels d'un projectile qui atteint le corps.
- Connaître la classification ainsi que la physiopathologie des différentes formes d'asphyxies rencontrées en médecine légale.

Catalogue suisse des objectifs

C FM

14

15, 16, 17, 18,

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Cours ex-cathedra.
- Demi-volée

POUR EN SAVOIR PLUS:

Handbook of forensic medicine

Burkhard Madea, Wiley & Sons, Incorporated, John

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119648628>

ISBN: 9781119648550 2022

Droit de la santé et médecine légale

Romano La Harpe, Marinette Ummel, Jean François Dumoulin

[Editions Médecine et Hygiène, Chêne-Bourg](#)

ISBN 978-2-88049-316-5 2014

Médecin et droit médical

BERTRAND Dominique UMMEL Marinette DUMOULIN Jean-François

Institut Universitaire de Médecine Légale

[Médecine et Hygiène](#) 3^{ème} édition 2009